

川崎町高齢者保健福祉計画 第10期介護保険事業計画

－ 3 業務深掘り解説書 －

【改訂版 Ver.2.0 － キックオフ会議反映】

保険料算定 ／ サービス見込量算定 ／ 施策の反映

令和8年5月（キックオフ会議後）

株式会社東京コンサルティング ／ 保介第41号

◆ Ver.2.0 改訂サマリー（キックオフ会議反映）

本書は、令和 8 年 5 月のキックオフ会議の確認内容を反映した改訂版である。入札段階の Ver.1.0 からの主な変更点は以下のとおり。

項目	Ver.1.0（入札段階）	Ver.2.0（キックオフ後）
アンケート発送	R8.7 下旬	R8.6 下旬（6 月 8～12 日に最終調整 打合せ→下旬発送）
第 1 回委員会	R8.10	R8.8 中旬（アンケート結果報告）
第 2 回委員会	R8.11	R8.11 下旬（第 9 期実績 11/28 を参 照）
第 3 回委員会	R8.12	R9.1 中旬（第 9 期実績 1/19 を参 照）
第 4 回委員会	R9.1	R9.2（最終確認・大枠完成版）
町担当者	（未確定）	近江氏（健康福祉課）＋佐古幸恵氏 （課長補佐）の 2 名体制
パブリックコメント	実施前提	第 9 期は未実施。第 10 期も任意（実 施するかは町と協議）
移動支援	タクシー助成終了の代替検討	社協・NPO 法人の福祉移送サービス （町委託）＋デマンドバス（バス会 社）に移行済
3 計画整合	論点として認識	地域福祉・障害はジャパンインター ナショナル総合研究所が受託。整合 方針は町が確認中

【改訂】入札段階の「保健福祉課介護保険係 大宮こずえ氏」は、キックオフ会議で確認された実担当（健康福祉課 近江氏・佐古幸恵氏）に修正した。組織名も「保健福祉課」から「健康福祉課」に修正。

第0章 業務全体像とアンケート後の位置付け

0-1. 業務全体の5フェーズ

第10期介護保険事業計画策定支援業務は、アンケート実施後の取組みも含めて以下の5フェーズで進行する。本書ではフェーズ②③④を「3業務」と総称し、深掘り解説の対象とする。

フェーズ	業務名	主な内容	時期（改訂版）
① F1～F4	前提整理～アンケート実施	施策評価・追加設問設計・調査票確定～回収・集計分析	R8.5～R8.8
② F5	サービス見込量算定	人口推計・認定者推計・サービス利用率算定・見込量推計	R8.8～R8.11
③ F5	施策の反映	前期振り返り→調査考察→ビジョン階層設定→計画反映	R8.8～R9.1
④ F5	介護保険料算定	標準給付費見込→負担分相当額→収納必要額→保険料基準額	R8.11～R9.2
⑤ F6・F7	委員会運営～計画書確定	4回の策定委員会・原案・町長答申（パブコメは任意）	R8.6～R9.3

【改訂】国の通知文書は夏頃以降に本格的に示される見込みのため、第1回委員会（R8.8中旬・アンケート結果報告）の後、国通知を踏まえて見込量・保険料算定に本格着手する。このため第1回と第2回（R8.11下旬）の間が約3ヶ月空く（第9期実績どおり）。

0-2. 3業務の連動関係

3業務は以下の順序で進行することが必須である。順序を逆転すると、施策の効果が保険料に反映されない・現場感覚と乖離した数値になる、という重大な問題が生じる。

【業務順序】

- ① サービス見込量算定（人口・認定者推計→サービス見込量）
- ② 施策の反映（見込量を施策で修正・施策効果を反映）
- ③ 介護保険料算定（修正後見込量から標準給付費・保険料基準額を算定）

0-3. 法令上の位置付け（介護保険法第117条）

市町村介護保険事業計画は、介護保険法第117条に基づき、3年を1期として策定する法定計画である。本計画には以下の事項を必ず定める必要がある。

- ① 認知症対応型共同生活介護等の必要利用定員総数（同条第2項第1号）
- ② 各年度における種類ごとの介護給付等対象サービスの量の見込み（同項第2号）
- ③ 地域支援事業の量の見込み（同項第3号）
- ④ 上記に係る費用の額・地域支援事業の見込量の確保のための方策

また、認知症基本法に基づき、第10期から「認知症施策推進計画」を含む構成とすることが第10期計画の特徴である。本書ではこの新規論点も視野に解説する。

第1章 介護保険料算定（第1号被保険者保険料）

1-1. 業務目的・基本ロジック

介護保険料算定は、3年間（第10期：令和9～11年度）に必要な保険料収納額を算定し、第1号被保険者の保険料基準額を決定する作業である。第1号被保険者の負担分相当額は、標準給付費と地域支援事業費を合算したものに第1号被保険者負担割合（第10期では23%）を乗じて算出する。

【算定基本式】

保険料基準額（年額）＝ 保険料収納必要額 ÷ 予定収納率 ÷ 加重平均調整率 ÷ 第1号被保険者数

ここで、保険料収納必要額＝第1号被保険者負担分相当額＋財政安定化基金償還金－介護給付費準備基金取崩額

1-2. 保険料算定8ステップ

Step	作業名	内容
1	標準給付費見込	F5見込量算定で確定したサービス見込量に、サービス種類別単価と加算率を乗じて、3年間の標準給付費を算出する。在宅・施設・地域密着型サービスごとに集計。
2	地域支援事業費	介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）／包括的支援事業／任意事業の費用を算定。総合事業は上限額管理が必要。
3	第1号負担分相当額	（標準給付費＋地域支援事業費）×第1号被保険者負担割合（第10期は23%）。第2号は27%、残り50%が公費。
4	調整交付金	国が後期高齢者割合・所得段階別人口で交付率を算定（標準5%）。後期高齢者割合の高い川崎町では交付率が高くなる傾向。
5	財政安定化基金償還金	第9期で財政安定化基金からの借入があれば、第10期で償還金を計上。なければ0。
6	介護給付費準備基金取崩	保険料抑制のため準備基金を取り崩す額を設定。基金残高は5月時点速報を取得済、6月に最終確定値を入手予定。
7	保険料収納必要額	Step1～6を反映した3年間の収納必要額を確定。
8	保険料基準額算定	収納必要額 ÷ 予定収納率 ÷ 加重平均調整率 ÷ 第1号被保険者数 で月額基準額を算出。13段階区分での所得段階別保険料を決定。

1-3. 自治体（川崎町）との調整プロセス【改訂】

- ① R8.8: 第9期実績整理（健康福祉課）／介護給付費準備基金残高確認（5月時点速報→6月確定値）
- ② R8.9～11: 国通知（夏以降）を踏まえ見込量試算結果の町内協議／調整交付金見込み
- ③ R8.12～R9.1: 保険料試算（複数パターン：基金取崩なし／50%取崩／全額取崩）
- ④ R9.1: 第3回策定委員会で計画素案とともに保険料試算を協議（4回構成の3回目）
- ⑤ R9.2: 第4回策定委員会で保険料基準額を決定・町長答申
- ⑥ R9.3: 条例改正案を町議会（3月議会）へ上程／可決後に公表

【改訂】基金残高は5月時点の速報値を町から取得可能、6月に最終確定値を入手予定（キックオフ確認）。第4回委員会は第9期実績ではパブコメを経ずに最終確認を行っており、第10期も同様の運用が想定される。

1-4. 実務上の留意点（8項目）

- ① 標準給付費は見える化システムで近隣団体（柴田町・大河原町・村田町等）と比較確認すること
- ② 第1号被保険者数は国立社会保障・人口問題研究所の地域別将来推計人口を活用
- ③ 予定収納率は過去5年実績の平均値を採用（第9期実績の確認必須）
- ④ 調整交付金率は所得段階別人口・後期高齢者割合の影響大。川崎町は高齢化率が高く高め見込み
- ⑤ 介護給付費準備基金は保険料抑制効果と次期負担との兼ね合いを考慮
- ⑥ 13段階区分の見直し検討（第9期と同じ区分か、見直すか）
- ⑦ 国保連へ介護保険料額の年間収納見込み報告（条例改正後）
- ⑧ 町民への保険料周知（広報誌・町HP・地区説明会・事業者連絡会）

1-5. 主要な出典・エビデンス

- ・厚労省 第10期作成準備（保険料・見込量）：
<https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001526855.pdf>
- ・MURC 第10期作成手引き
（2025.4）：https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2025/04/koukai_250425_01.pdf
- ・MURC 第10期ポイント解説 第二部
（2025.10）：https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2025/10/houkatsu_06_2510_02.pdf
- ・見える化システム：<https://mieruka.mhlw.go.jp/>
- ・介護保険事業状況報告（厚労省統計）：<https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/toukei/joukyou.html>

第 2 章 サービス見込量算定

2-1. 業務目的・基本ロジック

サービス見込量算定は、計画期間中（第 10 期：令和 9～11 年度）の各年度における、種類ごとの介護給付等対象サービスの量の見込み（介護保険法第 117 条第 2 項第 2 号）を確定する作業である。アンケート結果（F4）と現状の認定率・利用率を組合せて算出する。

【算定の基本ロジック】

見込量 = 将来人口 × 認定率 × 利用率 × 1 人当たり利用量

2-2. サービス見込量算定 8 ステップ

Step	作業名	内容
1	人口推計	国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」を活用。川崎町は高齢化率が高く人口減少地域のため、後期高齢者比率が高くなる傾向。
2	認定者推計	現状の認定率（要介護度別）を将来人口に乗じて推計。性別・年齢階級別認定率を活用。
3	利用率算定	国保連データ・介護給付費等実態統計から、サービス種類別の利用率（認定者中の利用者割合）を算定。
4	1 人当たり利用量	実績データから、月平均利用量（訪問介護なら時間数、通所介護なら回数等）を算定。
5	計画期間見込量推計	Step1～4 を組合せて、年度別・サービス種類別の見込量を推計。R9・R10・R11 の 3 年分。
6	アンケート結果反映	F4 結果から潜在ニーズや施策効果を考慮して見込量を補正。詳細は本章 2-3 節。
7	見える化システム登録・確認	近隣団体との比較確認。川崎町は仙南圏域（柴田町・大河原町・村田町・丸森町・蔵王町・七ヶ宿町）と比較。
8	給付費総額算定	見込量 × 単価で給付費総額を算定し、第 1 章の保険料算定 Step1（標準給付費見込）の基礎データとなる。

【施設の町外利用・住所地特例の反映】

キックオフ会議で、川崎町は町内施設が縮小傾向にあり、町外施設の利用（住所地特例）が相当数あることが確認された。見込量算定では、町外施設利用者・住所地特例該当者を適切に算入し、施設サービス見込量が町内供給量に過度に縛られないよう留意する。

2-3. アンケート結果の見込量への反映 5 方法

F4 のアンケート結果（一般高齢者 1,000 名・認定者 300 名）は、見込量算定に以下の 5 方法で反映する。

- ① 認定率の補正：未申請者・潜在ニーズの把握から認定率を上方補正（特に独居・老老介護世帯）
- ② サービス利用意向の反映：「利用したいが利用していない」回答者を踏まえ、利用率を補正
- ③ 施策効果の見込み：通いの場参加促進・介護予防体操等で軽度認定者の重度化抑制効果を見込量に反映
- ④ 新規事業の見込み：認知症カフェ・チームオレンジ等の新規事業の対象者規模を見込量に追加
- ⑤ 地区別の補正：7 地区別アンケート結果から、地区別の見込量・サービス偏在を補正

2-4. 自治体（川崎町）との調整プロセス【改訂】

- ① R8.8：F4 集計分析結果を健康福祉課（近江氏・佐古氏）と共有
- ② R8.8：第 9 期実績との比較・将来推計データの確認（社人研データの最新確認）
- ③ R8.8 中旬：第 1 回策定委員会でアンケート結果報告（4 回構成の 1 回目）
- ④ R8.9～11：国通知（夏以降）を踏まえた見込量試算（施策反映なし／中程度／積極反映）
- ⑤ R8.11 下旬：第 2 回策定委員会で第 9 期振り返り・見込量の方向性を協議
- ⑥ R8.11～12：見える化システムへの登録・近隣団体との比較確認

2-5. 主要な出典・エビデンス

- ・国立社会保障・人口問題研究所：<https://www.ipss.go.jp/>
- ・MURC 第 10 期 各種調査の見直し案：
https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2024/05/houkatsu_06_03_01.pdf
- ・MURC 総合事業ワークシート
(Excel)：https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2025/04/houkatsu_02_2504_01.zip
- ・見える化システム：<https://mieruka.mhlw.go.jp/>
- ・介護給付費等実態統計：<https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/45-1.html>

第3章 施策の反映

3-1. 業務目的

「施策の反映」は、第9期計画の取組実績の振り返りと第10期に向けた論点を踏まえ、F2 28 施策×5 軸評価で◎○判定された施策をビジョン・中目標・小目標の階層構造に位置付け、計画書本体に反映する作業である。第10期から認知症基本法対応の独立章を新設することが特徴である。

キックオフ会議では、町の方針として『第9期計画から体系を変えず継続する』ことが基本確認された。一方、国県が第10期計画に必須として求める項目（認知症施策推進計画等）は新規に盛り込む。ただし、地域福祉計画・障害計画の同時策定（ジャパンインターナショナル総合研究所が受託）との整合次第で体系が変わる可能性があり、町が地域・障害担当に確認中である。

3-2. 厚労省「施策反映の手引き」3ステップ

STEP	段階	内容
STEP1	前期振り返り	第9期計画の取組実績・参加者影響・地域影響を評価。各施策の達成状況をPDCAで総括。
STEP2	調査・考察	F4のニーズ調査・在宅介護実態調査・新規調査5種の結果を考察。好事例調査（先進自治体）も参照。
STEP3	取組と目標	ビジョン→中目標→施策→小目標の階層を設定。F2評価で◎○の施策を計画に反映。アウトカム指標を設定。

3-3. ビジョン階層モデル

施策の反映は、以下の4階層で体系化する。第9期計画の体系（健康づくり推進／高齢者が安心して暮らせるまちづくり等）を基本的に継承する。

- ① ビジョン（計画の基本理念）：第9期の基本理念を基本的に継承
- ② 中目標（基本目標）：第9期の体系（健康づくり推進・安心して暮らせるまちづくり等）を継承
- ③ 施策（具体的取組）：F2の28施策のうち◎○判定20施策を中心に体系化
- ④ 小目標（成果指標）：通いの場参加率・認知症サポーター数・チームオレンジ整備等

3-4. 規範的統合の概念【改訂】

「規範的統合」とは、複数の計画・施策間で目指す姿（規範）を統合することである。川崎町では以下を統合する。同時策定中の地域福祉計画・障害計画はジャパンインターナショナル総合研究所が受託しており、整合のための情報共有・調整が必要となる。

- ・第6次川崎町長期総合計画（令和11年度まで）の高齢者・福祉部門との整合（土台計画）
- ・地域福祉計画（JI総研受託・同時策定）—— 重層的支援体制・移送サービス等との整合
- ・障害者計画（JI総研受託・同時策定）—— 65歳以上の障がい者支援・福祉移送サービスとの連携
- ・健康かわさき21計画・データヘルス計画—— 健康寿命延伸・項目相互参照（「この部分は健康かわさき21に掲載」等の文言整合）
- ・社協の地域福祉活動計画—— 社協独自計画。フレイル・介護予防事業のタイアップで連動

【改訂】地域福祉計画で理念を掲げ高齢者計画がそれに則る形になると専門性が変わるため、足並みを揃えるタイミングの調整が必要（キックオフ確認）。データヘルス計画・健康かわさき21との整合は項目相互参照の文言を入れる方向で町が確認中。

3-5. 認知症基本法 7 基本的施策との対応

認知症基本法の基本的施策（第15～21条）に対応した第10期計画の章構成として、第5章「認知症施策推進計画」を独立新設する必要がある。基本法の7基本的施策と川崎町施策の対応を以下に整理する。

条文	基本的施策	川崎町の対応（F2 運動）
第15条	教育の推進	F2 No.18 認知症サポーター養成（既存550名）の拡大／企業・学校サポーター
第16条	予防に関する施策	F2 No.20 認知症初期集中支援チーム強化／国保川崎病院との連携
第17条	保健医療・福祉サービス提供体制	F2 No.19 認知症カフェ展開／チームオレンジ整備（基本法対応最重要）
第18条	相談体制の整備	F2 No.16 包括センター機能強化（社協運営）／F2 No.21 推進員配置
第19条	意思決定支援・権利擁護	ACP 推進（F2 No.15）／成年後見制度利用促進／日常生活自立支援事業
第20条	研究等の推進	F4 新規調査(1)認知症本人・家族調査（30～50組）／JAGES等の活用
第21条	若年性認知症に関する施策	F2 No.22 若年性認知症支援（宮城県コーディネーター連携）

【特に重要：第3条 本人意見反映義務】

認知症基本法第3条は、認知症の人の意思の尊重と社会参加機会確保を求めている。市町村は計画策定にあたり当事者の意見を反映する義務を負う。川崎町ではF4 新規調査(1)認知症本人・家族調査【最優先◎】（30～50組）の半構造化インタビューで本人発言を直接聴取し、計画の第5章に反映する。

3-6. 自治体（川崎町）との調整プロセス【改訂】

- ① R8.8：第9期計画の振り返り（健康福祉課・地域包括支援センター・社協と協議）
- ② R8.8 中旬：第1回策定委員会でアンケート結果報告
- ③ R8.11：F2 28 施策×5 軸評価結果を踏まえた施策の重点化案を内部協議
- ④ R8.11 下旬：第2回策定委員会で施策の方向性を協議
- ⑤ R8.12～R9.1：規範的統合の検討（地域福祉計画・障害計画＝JI 総研／健康かわさき21等との整合）
- ⑥ R9.1 中旬：第3回策定委員会で計画素案・サービス見込量・保険料試算を協議

3-7. 主要な出典・エビデンス

- ・厚労省 施策反映のための手引き：<https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000532251.pdf>
- ・厚労省 主な認知症施策について：
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000076236_00006.html

- ・厚労省 総合事業ガイドライン：<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000074126.html>
- ・MURC 地域包括ケア計画 トップ：https://www.murc.jp/houkatsu_06/
- ・JAGES（日本老年学的評価研究）：<https://www.jages.net/>

第4章 自治体との調整方法

4-1. 調整の5原則（横断的視点）

- ① 町担当者を「主体」、受託事業者を「支援者」と位置付ける（責任所在の明確化）
- ② 数値・データの最終確認は必ず町側が実施（特に給付費・保険料は条例改正の根拠）
- ③ 首長・課長級への報告タイミングを事前合意（委員会開始前に課長を交えた整合確認を行う）
- ④ 議会对応は町担当者、説明資料は受託事業者作成支援
- ⑤ 策定委員会開催のたびに「何を決定するか」を事前明確化

4-2. 主要な調整会議体（川崎町版）【改訂】

会議体	目的・参加者	活用フェーズ	頻度
受託事業者打合せ	実務協議（受託事業者・健康福祉課 近江氏・佐古氏）	全期間	隔週～月次
庁内検討会議	町関係課（健康福祉課・地域振興課・町民生活課・財政・税務）	F2・F5・F7	月次
策定委員会	計画素案・原案の審議（1委員会×4回）	F6	R8.8～R9.2
課長を交えた整合確認	委員会開始前・節目に課長同席で関連計画整合	F5・F7	随時
民生委員会議	地域の声の集約（アンケートで拾えない声）	F4・F5	既存会議活用
社協・NPO連携	福祉移送サービス・地域福祉活動計画との連携	F2・F5	随時

【改訂】移送・デマンドの所管は地域振興課・町民生活課であることがキックオフで判明。庁内検討会議の関係課に追加。委員会前の課長同席整合確認を会議体に明記（キックオフで町と合意）。

4-3. エスカレーションパス（4階層）【改訂】

レベル	受託事業者側	川崎町側	対象事項
Lv1	若山・高橋・山内	近江氏・佐古幸恵氏（健康福祉課）	実務的な数値・データ調整／日常的な業務協議
Lv2	河崎（事業責任者）	健康福祉課長	方針・予算・スケジュール／関連計画整合
Lv3	事業者役員	町長部局・副町長	重大変更・追加業務／保険料水準の方向性
Lv4	－	町長	計画の根幹に関わる判断（保険料基準額決定等）

4-4. データ提供のルール

- ・国保連データ：町担当者経由で取得／受託事業者は集計表のみ受領
- ・住民基本台帳：法的制限あり／対象者抽出（一般高齢者 1,000 名・認定者 300 名）に限定。町がリスト・ラベル作成
- ・認定者名簿：個人情報保護条例に基づく取扱／匿名化必須
- ・給付実績データ：見える化システム経由で集計値のみ閲覧可
- ・基金残高：5 月時点速報→6 月確定値を町から提供
- ・移送サービス実績：地域振興課・町民生活課所管。決算統計（令和 7 年度）からピックアップ

4-5. パブリックコメントの扱い【改訂】

第9期計画では住民の声の反映（パブリックコメント）を実施していないことがキックオフ会議で確認された。第10期も実施は任意であり、実施するかどうかは町と協議のうえ判断する。実施する場合の標準的な運営は以下のとおり。

- ① 実施する場合：実施期間 30 日以上を確保（年末年始を含む場合は期間設定に注意）
- ② 公表媒体：町 HP・町広報誌・町役場健康福祉課窓口・公民館
- ③ 3 点セット公表：計画素案／概要版／意見提出様式
- ④ 実施しない場合：第 9 期同様、策定委員会での審議をもって住民意見の反映に代える運用とし、民生委員会等で拾った地域の声を計画に反映

第5章 全体スケジュール【改訂】

5-1. 3業務統合スケジュール表（キックオフ確認反映）

時期	見込量算定	施策の反映	保険料算定	策定委員会	計画書本体
R8.6-7	—	—	基金残高（6月確定）	—	—
R8.8	F4 結果整理／推計準備	第9期振り返り（STEP1）	第9期実績整理	第1回（R8.8中旬）	骨子検討
R8.9-10	Step1-5 人口・認定者・推計（国通知反映）	STEP2 調査考察	—	—	—
R8.11	Step6-8 補正・見える化登録	STEP3 ビジョン階層	Step1-2 給付費・地域支援事業費	第2回（R8.11下旬）	素案作成
R8.12-R9.1	最終確定	認知症章独立化／規範的統合	Step3-7 試算（複数パターン）	第3回（R9.1中旬）	素案
R9.2	—	最終調整	Step8 保険料基準額決定	第4回（R9.2）	原案・町長答申
R9.3	—	—	条例改正・議会上程	—	計画確定・公表

【改訂】第1回（R8.8中旬）はアンケート結果報告。国通知が夏以降のため、見込量・保険料の本格着手は第1回後。第2回（R8.11下旬）・第3回（R9.1中旬）は第9期実績（11/28・1/19）を参照。第4回（R9.2）で最終確認・町長答申。

5-2. クリティカルパス（7項目）【改訂】

全体スケジュールにおいて、遅延が許されない最重要項目を以下に整理する。

- ① R8.6 下旬 アンケート発送：最優先。6月8～12日の最終調整打合せを経て下旬発送（遅延すると全工程が後ろ倒し）
- ② R8.7 末 アンケート回収：1ヶ月強の回収期間（第9期回収率52.6%を上回る目標）
- ③ R8.8 中旬 第1回策定委員会：アンケート結果報告・計画策定方針の決定
- ④ 国通知（夏以降）→見込量推計：国の方向性を待って本格着手するため、通知時期に左右される
- ⑤ R8.11 下旬 第2回策定委員会：見込量・施策方向性の確定
- ⑥ R9.1 中旬 第3回策定委員会：素案・保険料試算の協議
- ⑦ R9.2 第4回委員会→R9.3 条例改正・3月議会上程：保険料決定・町長答申を経て3月議会（最終定例会）への上程必須

第6章 改訂履歴・参考リンク集

6-1. 改訂履歴

版	日付	改訂内容
Ver.1.0	令和8年4月	初版作成（入札段階）
Ver.2.0	令和8年5月	キックオフ会議反映（スケジュール前倒し・担当者・移動支援実態・パブコメ任意・3計画整合）
（予定）	受託後 R8.8 以降	アンケート結果・国通知を踏まえた改訂

6-2. 厚労省関連リンク集

- ・厚労省 施策反映のための手引き: <https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000532251.pdf>
- ・厚労省 進捗管理の手引き: <https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000340994.pdf>
- ・厚労省 第10期作成準備: <https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001526855.pdf>
- ・厚労省 第10期介護保険事業計画作成説明会:
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000138653_00007.html
- ・厚労省 主な認知症施策について:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000076236_00006.html
- ・見える化システム: <https://mieruka.mhlw.go.jp/>
- ・介護保険事業状況報告: <https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/toukei/joukyou.html>
- ・介護給付費等実態統計: <https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/45-1.html>

6-3. MURC 関連リンク

- ・MURC 介護保険事業計画作成の手引き
Ver.2: https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2023/05/houkatsu_06_2305_01.pdf
- ・MURC 第10期作成手引き
(2025.4): https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2025/04/koukai_250425_01.pdf
- ・MURC 第10期ポイント解説 第二部
(2025.10): https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2025/10/houkatsu_06_2510_02.pdf
- ・MURC 第10期各種調査の見直し案:
https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2024/05/houkatsu_06_03_01.pdf
- ・MURC 総合事業ワークシート
(Excel): https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2025/04/houkatsu_02_2504_01.zip
- ・MURC 地域包括ケア計画 トップ: https://www.murc.jp/houkatsu_06/

6-4. 研究機関・先進自治体事例

- ・国立社会保障・人口問題研究所: <https://www.ipss.go.jp/>
- ・JAGES（日本老年学的評価研究）: <https://www.jages.net/>
- ・八王子市 保険料算定: <https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/004/002/004/p003763.html>
- ・札幌市北区 保険料算定: https://www.city.sapporo.jp/kitaku/tetsuzuki/hoken_nenkin/kaigo_keisan.html